リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月12日（木）

第61号　朝刊

きょうの紙面　▶ 脳卒中 × 血圧管理　▶ 骨折 × 退院直後　▶ 訪問リハ × 診療報酬　▶ 短信 8本

■ 脳卒中 × 血圧管理

脳梗塞後の降圧目標120未満 心血管イベントが2割減

ブラジル30施設の4,368人のRCT　10.9%対13.5%、腎機能の低下は強化群で多く

脳梗塞や一過性脳虚血発作（TIA）のあと、血圧をどこまで下げればよいかは決着していなかった。ブラジル30施設の非盲検ランダム化試験OPTIMAL-STROKEは、既往があり血圧が高い4,368人を、収縮期血圧120mmHg未満を目標にする群と140mmHg未満を目標にする群に分けた。

最初の3か月を除く追跡中の収縮期血圧は平均122.0対135.2mmHgで、差は13.1mmHg。中央値3.9年の追跡で、心血管死・心筋梗塞・脳卒中・不安定狭心症や心不全の入院の複合は10.9%対13.5%に起き、ハザード比は0.79（95%信頼区間0.67～0.94）だった。重い有害事象の全体の頻度は両群で同程度だった。

一方、腎機能が半分以下に落ちる、末期腎不全に進むといった腎の複合アウトカムは強化群で多かった。非盲検で、対象はブラジルの人たちに限られる。回復期では、低めの目標で降圧する人の立ち上がりや歩行の時のふらつき、脱水の兆しを、リハの場面で見ておく必要がある。



下げるほど守れる。だから、ふらつきを見る目が要る。

出典 NEJM（OPTIMAL-STROKE）↗

数字で見る

4,368人
非盲検RCTの対象者

0.79
心血管イベントのハザード比

13.1 mmHg
両群の収縮期血圧の差

■ 骨折 × 退院直後

退院後14日の骨折リスク 入院しない人の1.77倍

2023年に入院した45歳超の約28万人を、年齢・性別・持病をそろえた入院しなかった人と比べた。骨粗鬆症による主な骨折のリスクは退院後14日で1.77倍（95%信頼区間1.47～2.14）、30日で1.28倍、1年で1.03倍とほぼ差がなくなった。

入院の日数が長いほど、回数が多いほどリスクは高かった。女性は90日で一時的に差が消え、



男性はその傾向がなかった。観察研究で因果は言えないが、退院直後の2週間に向けた転倒予防の準備には意味がある。

出典 Osteoporosis International↗

■ 訪問リハ × 診療報酬

訪問看護のPT・OT・ST 提供内容を8分類で調査へ

2026年度診療報酬改定の結果を確かめる特別調査で、訪問看護ステーション向けの調査票に、PT・OT・STによる訪問看護で提供した内容を尋ねる設問が入った。基本動作、身体機能、ADL・IADL、高次脳機能、コミュニケーション、摂食・嚥下、福祉用具・住環境、家族への指導の8つから選ぶ。

退院前カンファレンスへの同席や目標の共有など、看護職員との連携の



方法も尋ねる。対象は2026年10月の提供分で、結果が出るのは先だ。訪問のリハで何をしているかが数字になれば、次の改定の議論の材料になる。

出典 中医協 総会（第662回）↗

短信

〈心不全〉**サルコペニアの嚥下障害は24%**

心不全で入院した65歳以上363人の後ろ向き研究。1年の死亡・再入院はハザード比2.53と高かった。

出典 Circulation Reports↗

〈心不全〉**絶食48時間未満で嚥下障害が少ない**

急性心不全644人から傾向スコアで121組。48時間未満の再開で退院時の嚥下障害のオッズ比0.19。

出典 Circulation Reports↗

〈呼吸リハ〉**退院後の呼吸リハ、選んだのは在宅**

COPD入院後の145人に選ばせると通所は1人だけ。在宅プログラムの前後比較で生活の質と歩数が改善。

出典 Ann Am Thorac Soc↗

〈脳卒中〉**発症24～72時間の血栓回収**

中国35施設の336人のRCT。90日の機能はオッズ比1.74で改善、症候性頭蓋内出血4.8%対0%。 出典 NEJM↗

〈リハ政策〉**国のリハ計画、進める鍵は主導**

WHO5地域19か国の聞き取り。政治の後押しと保健省の主導、関係者の参加が計画づくりを進めた。

出典 Disabil Rehabil↗

〈心臓リハ〉**心リハの開始は4割、格差も**

デンマークの虚血性心疾患9万3,159人。6か月以内の心臓リハ開始は41.2%で、社会経済的な差があった。

出典 Eur J Prev Cardiol↗

〈医療安全〉**医療事故の報告、累計3,982件**

日本医療安全調査機構の10月の現況報告。10月の報告は35件、院内調査の完了は89.4%。 出典 GemMed↗

〈制度〉**財政審、外来医療の集約化を提案**

11月4日の財政制度分科会で財務省が、病床数の適正化と診療所を含む外来医療の集約化を求めた。 出典 GemMed↗